

Einführung in das Alphabetische Verzeichnis zur ICD-10-GM (Diagnosenthesaurus)

Das Alphabetische Verzeichnis zur ICD-10-GM (Diagnosenthesaurus) wird im ODT-, PDF- und TXT (CSV)-Format herausgegeben. In der folgenden Übersicht werden die wichtigsten Entwicklungsschritte des Alphabetischen Verzeichnisses zur ICD-10-GM bzw. des ICD-10-Diagnosenthesaurus dargestellt:

Version / Beginn Geltungszeitraum	Umfang	Entwicklung
1.1 / 02.1997	ca. 10.000	Erste Ausgabe des ICD-10-Diagnosenthesaurus durch das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland (Zi)
2.0 / 06.1998	ca. 27.800*	- Anpassung an die Version 1.1 der ICD-10 und weiterer Ausbau des Textbestandes - erstmalig Druckdarstellung als "Spiegelstrichfassung"
2.1 / 01.1999	ca. 27.800*	Anpassung an die Version 1.2 der ICD-10 und Update
2.2 / 02.1999	ca. 27.800*	Formales Update
3.0 / 01.2000	ca. 30.700*	Anpassung an die Version 1.3 der ICD-10-SGBV und Aufnahme von Diagnostexten aus dem vertragsärztlichen Bereich mit den Schwerpunkten Gynäkologie/Geburtshilfe und Orthopädie
3.1 / 11.2000	ca. 30.800*	Nur als EDV-Fassung erschienen
3.1 / 06.2002	nicht bekannt	Nur als Buchausgabe erschienen (Dreiländerausgabe in der Bearbeitung von Dr. med. Bernd Graubner)
4.0 / 01.2001	ca. 31.200*	Anpassung an die Version 2.0 der ICD-10-SGB-V zur Unterstützung der Einführung des G-DRG-Systems
2004	ca. 53.800*	- Anpassung an die Version 2004 der ICD-10-GM und Integration der Inklusive aus deren Systematischem Verzeichnis - Beginn der Integration des Alphabetischen Verzeichnisses der WHO-Ausgabe der ICD-10
2005	ca. 64.600*	- Anpassung an die Version 2005 der ICD-10-GM und Fortsetzung der Integration des Alphabetischen Verzeichnisses der WHO-Ausgabe der ICD-10 - Übergang von der Bezeichnung "ICD-10-Diagnosenthesaurus" auf die Bezeichnung "Alphabetisches Verzeichnis zur ICD-10-GM (Diagnosenthesaurus)"
2006	ca. 73.800*	- Anpassung an die Version 2006 der ICD-10-GM und Abschluss der Integration des Alphabetischen Verzeichnisses der WHO-Ausgabe der ICD-10 - Aufnahme der Einträge aus der Tabelle der Neubildungen in die EDV-Fassung - Reduzierung des Umfangs der Buchfassung durch Ausbau des Verweissystems
2007	ca. 74.200*	Anpassung an die Version 2007 der ICD-10-GM und weitere Reduzierung des Umfangs der Buchfassung
2008	ca. 75.700*	- Anpassung an die Version 2008 der ICD-10-GM - Aufnahme klinisch relevanter Einträge, die von Ärzten auf Todesbescheinigungen verwendet wurden - Aufnahme von Einträgen zum Themenkreis Allergie und Überempfindlichkeit gegenüber Medikamenten und Medikamentenhilfsstoffen
2009	ca. 76.000*	- Anpassung an die Version 2009 der ICD-10-GM - Aufnahme von Einträgen, die sich bei der Auswertung von Arzneimittel-Fachinformationen ergeben haben
2010	ca. 76.250*	- Anpassung an die Version 2010 der ICD-10-GM - Aufnahme von Einträgen, die sich bei der Auswertung von Arzneimittel-Fachinformationen ergeben haben
2011	ca. 76.400*	- Anpassung an die Version 2011 der ICD-10-GM - Aufnahme von Einträgen, die sich bei der Auswertung von Arzneimittel-Fachinformationen ergeben haben
2012	ca. 76.500*	- Anpassung an die Version 2012 der ICD-10-GM - Aufnahme von Einträgen, die sich bei der Auswertung von Arzneimittel-Fachinformationen ergeben haben

Version / Beginn Geltungszeitraum	Umfang	Entwicklung
2013	ca. 76.900*	- Anpassung an die Version 2013 der ICD-10-GM - Aufnahme von Einträgen, die sich bei der Auswertung von Arzneimittel-Fachinformationen ergeben haben
2014	ca. 77.000*	- Anpassung an die Version 2014 der ICD-10-GM - Aufnahme von Einträgen, die sich bei der Auswertung von Arzneimittel-Fachinformationen ergeben haben
2015	ca. 77.400*	- Anpassung an die Version 2015 der ICD-10-GM - Aufnahme von Einträgen, die sich bei der Auswertung von Arzneimittel-Fachinformationen ergeben haben - Aufnahme von Texten für Seltene Erkrankungen
2016	ca. 78.700*	- Anpassung an die Version 2016 der ICD-10-GM - Aufnahme von Einträgen, die sich bei der Auswertung von Arzneimittel-Fachinformationen ergeben haben - Aufnahme von Texten für Seltene Erkrankungen
2017	ca. 79.700*	- Anpassung an die Version 2017 der ICD-10-GM - Aufnahme von Einträgen, die sich bei der Auswertung von Arzneimittel-Fachinformationen ergeben haben - Aufnahme von Texten für Seltene Erkrankungen
2018	ca. 79.800*	- Anpassung an die Version 2018 der ICD-10-GM - Aufnahme von Texten für Seltene Erkrankungen
2019	ca. 80.800*	- Anpassung an die Version 2019 der ICD-10-GM - Aufnahme von Texten für Seltene Erkrankungen
2020	ca. 82.500*	- Anpassung an die Version 2020 der ICD-10-GM - Aufnahme von Texten für Seltene Erkrankungen - Aufnahme von Einträgen, die sich bei der Auswertung von Arzneimittel-Fachinformationen ergeben haben
2021	ca. 83.500*	- Anpassung an die Version 2021 der ICD-10-GM - Aufnahme von Texten für Seltene Erkrankungen
2022	ca. 84.300*	- Anpassung an die Version 2022 der ICD-10-GM - Aufnahme von Texten für Seltene Erkrankungen
2023	ca. 86.200*	- Anpassung an die Version 2023 der ICD-10-GM - Aufnahme von Texten für Seltene Erkrankungen
2024	ca. 88.000*	- Anpassung an die Version 2024 der ICD-10-GM - Aufnahme von Texten für Seltene Erkrankungen
2025	ca. 89.000*	- Anpassung an die Version 2025 der ICD-10-GM - Aufnahme von Texten für Seltene Erkrankungen
2026	ca. 89.600*	- Anpassung an die Version 2026 der ICD-10-GM - Aufnahme von Texten für Seltene Erkrankungen

* Der Umfang bezeichnet hier die Anzahl der ausformulierten Diagnosentexte inkl. Verweisdatensätzen.

Das Alphabetische Verzeichnis zur ICD-10-GM entsteht auf der Basis normalsprachlich ausformulierter Diagnosentexte (z.B. "Thorakaler Bandscheibenvorfall"), die den Bestand der sog. EDV-Fassung bilden. Aus diesen Diagnosentexten entstehen durch Permutation (Veränderung der Wortreihenfolge) die Einträge für die Buchfassung (z.B. "Bandscheibe, Vorfall, thorakal" und "Vorfall, Bandscheibe, thorakal"). Diese permutierten Einträge werden alphabetisch sortiert und sind jeweils unter ihren führenden Wörtern (Leitbegriffen) in der Buchfassung zu finden, die wegen der besseren Übersichtlichkeit als Spiegelstrichfassung aufgebaut ist. Auf Grund dieses Vorgehens enthält die Buchfassung jeweils etwa doppelt so viele Einträge wie die entsprechende EDV-Fassung.

Da die Buchfassung möglichst nicht weiter wachsen soll, werden nicht mehr alle Permutationen in die Buchfassung übernommen.

1. Aufbau der Buchfassung

Für die Sortierreihenfolge der Einträge gelten folgende Regeln:

- ä, ö, ü sind wie ae, oe, ue und ß ist wie ss einsortiert.
- Buchstaben mit diakritischen Zeichen (ç, é usw.) sind wie ihre Grundbuchstaben eingeordnet.

- Bei der Sortierfolge stehen Leerzeichen vor Bindestrichen und Auslassungszeichen, danach folgen Ziffern und zuletzt Buchstaben.
- Diagnosen, die mit Ziffern beginnen, werden unter ihrem ersten Buchstaben eingeordnet.

In der vorliegenden Spiegelstrichfassung sind die Anfangswörter jedes Datensatzes bis zum Textende bzw. ersten Komma fett gedruckt ("Haupteintrag").

2. Inhalt

Bei der Erarbeitung des Alphabetischen Verzeichnisses zur ICD-10-GM wurden bisher die folgenden Begriffssammlungen berücksichtigt:

- Begriffe der ICD-10-Systematik
- Begriffe des Alphabetischen Verzeichnisses zur ICD-10-WHO
- Begriffe des Thesaurus der ehemaligen Arbeitsgruppe Klartextanalyse der GMDS, später gepflegt am Zentrum der Medizinischen Informatik des Klinikums der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main
- Beiträge ärztlicher Berufsverbände mit vorwiegend Routinediagnosen aus den Fachgebieten Allgemeinmedizin, Anästhesiologie, Augenheilkunde, Kinder- und Jugendheilkunde sowie Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
- "Göttinger Diagnosen" (ICD-9-/ICD-10-Diagnosensammlung) von Dr. Bernd Graubner (anfänglich für die Georg-August-Universität Göttingen zusammengestellt)
- Begriffe der ICD-9-Diagnosensammlung der IMS GmbH, Frankfurt am Main (Institut für Medizinische Statistik)
- Begriffe aus dem von Dr. Reinhart Köhler erarbeiteten Diagnosenverzeichnis des gynäkologischen EDV-Anwenderkreises GYNAMED
- Begriffe, die 1997 im ICD-10-Modellversuch der Kassenärztlichen Vereinigungen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gesammelt worden sind
- Begriffe aus dem ADT-Panel des Zi (Zeitraum 1998/99), das auf anonymisierten Abrechnungsdaten niedergelassener Ärzte verschiedener Fachrichtungen beruht
- Begriffe aus der Auswertung von Todesbescheinigungen (im Rahmen eines gemeinsamen Projektes des Statistischen Bundesamtes und des DIMDI)
- Begriffe aus der Auswertung von Arzneimittel-Fachinformationen durch die Medizinische Medien Informations GmbH (MMI)
- Begriffe für Seltene Erkrankungen aus dem Projekt "Kodierung von Seltenen Erkrankungen"

3. Methodik und Erarbeitung

Die Begriffssammlungen, die bisher in das Alphabetische Verzeichnis zur ICD-10-GM aufgenommen worden sind, befanden sich in unterschiedlichem Bearbeitungszustand und mussten auf ein einheitliches und vergleichbares Niveau gebracht werden. Dazu war es erforderlich, Datenbestände, die nur nach der ICD-9 verschlüsselt waren, mit den ICD-10-Schlüsselnummern zu versehen und bei den bereits ICD-10-kodierten Datenbeständen die Schlüsselnummern auf ihre Richtigkeit zu prüfen.

Die **Quellentexte** der Datenbestände wurden in der Regel so übernommen, wie sie mitgeteilt worden sind. Viele dieser Quellentexte reflektieren den tatsächlichen medizinischen Sprachgebrauch, andere spiegeln den Stand der medizinischen Wissenschaft und offizielle Nomenklaturen wider. Da die Aufgabe darin bestand, eine Hilfe für die Praxis zu erstellen, wurden insbesondere die tatsächlich benutzten Begriffe aufgenommen. Sie wurden nicht auf Vorzugsbegriffe standardisiert. Deswegen wurden auch seltene Begriffe berücksichtigt, sofern sie in einer der Begriffssammlungen auftraten.

Offensichtliche Schreibfehler wurden korrigiert. Bei den **Schreibweisen** wurden vor allem das DUDEN-Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke, das Klinische Wörterbuch von Pschyrembel sowie die amtliche ICD-10-GM beachtet. Bei Fachbegriffen, die nur aus einem Wort bestehen, wurde in der Regel die eingedeutschte Schreibweise verwendet. Für andere Schreibweisen wurden meistens Verweise eingearbeitet. Ab der Version 2005 des Alphabetischen Verzeichnisses zur ICD-10-GM wird die neue Rechtschreibung verwendet.

In Ausnahmefällen wurden zur **Erläuterung** Texte in eckigen Klammern eingefügt. Dabei handelt es sich meistens um Abkürzungen bzw. deren ausgeschriebene Form oder um Syndrombezeichnungen.

Bezeichnungen von **Prozeduren** wurden nur dann in das Alphabetische Verzeichnis zur ICD-10-GM aufgenommen, wenn sie Bestandteil der ICD-10-GM sind (z.B. einige geburtshilfliche Prozeduren). Für die Verschlüsselung von Operationen muss der amtliche Operationen- und Prozedurenschlüssel OPS

verwendet werden (z.B. Amputationen, Cholezystektomie oder Adenotomie). Krankheitszustände, die zu einer Operation führen oder bei denen der Zustand nach einer Operation dokumentiert werden soll, sind meistens mit der jeweiligen Diagnose zu verschlüsseln und zum Teil auch im Alphabetischen Verzeichnis zur ICD-10-GM enthalten, wenn sie häufig in den Quellentexten vorgekommen sind (z.B. "Mitralklappe, Ersatz, Zustand nach": Z95.4).

Im Alphabetischen Verzeichnis zur ICD-10-GM sind die Schlüsselnummern in der Form nachgewiesen, in der sie in der ICD-10-GM enthalten sind. Das bedeutet, dass **primäre und sekundäre Schlüsselnummern als sog. terminale Schlüsselnummern angegeben** werden (drei- oder vierstellig, falls jeweils nicht weiter unterteilt, oder fünfstellig). Die Schlüsselnummernzusätze Kreuz, Stern oder Ausrufezeichen sind hinzugesetzt. Diejenigen Schlüsselnummern des Kapitels XXI, die in der ICD-10-GM nur dreistellig sind, in der WHO-Ausgabe der ICD-10 jedoch vierstellig untergliedert sind, werden in diesem Alphabetischen Verzeichnis nur als dreistellige Schlüsselnummern nachgewiesen (z.B. Z02).

Eine Diagnose soll grundsätzlich so spezifisch wie möglich verschlüsselt werden. So ist z.B. bei der Verschlüsselung von Neubildungen an einer bestimmten Lokalisation die Verwendung der **Tabelle der Neubildungen** hilfreich. Hier findet man in tabellarischer Aufbereitung die Codes für die verschiedenen Arten von Neubildungen (gutartig, bösartig usw.) an den verschiedenen Lokalisationen und kann für eine bestimmte Lokalisation und für eine bestimmte Art der Neubildung den entsprechenden spezifischen Code entnehmen.

Die **Zusatzkennzeichen zur Dokumentation der Diagnosesicherheit** (V [Verdachtsdiagnose bzw. auszuschließende Diagnose], Z [(symptomloser) Zustand nach der betreffenden Diagnose], A [ausgeschlossene Diagnose] und G [gesicherte Diagnose]) und die **Zusatzkennzeichen für die Seitenlokalisation** (R [rechts], L [links] und B [beidseitig]) sind im Alphabetischen Verzeichnis zur ICD-10-GM nicht enthalten.

In der Buchfassung kann man aufgrund der **Textpermutationen** nicht nur nach einer Diagnose (z.B. "Fraktur, Femur" oder "Fieber, rheumatisch"), sondern beispielsweise auch nach Lokalisationen (z.B. "Femur, Fraktur") oder Modifikatoren (z.B. "Großzellig, Lymphom") suchen. Um ein unnötiges Aufblähen der Buchfassung zu vermeiden, werden häufig verwendete Adjektive, d.h. solche, die mehr als fünfzigmal im Alphabetischen Verzeichnis vorkommen (z.B. "akut", "chronisch", "bösartig"), nur in Verweisen aufgeführt und nur im Ausnahmefall als Suchbegriffe verwendet ("reduzierte Permutierung"). Lateinische Diagnosentexte wurden nur in Ausnahmefällen permutiert.

Folgende **formale Regeln für die Textbearbeitung** wurden in der Ursprungsdatei der Buchfassung eingehalten:

- Der Textanfang steht immer in Großbuchstaben.
- Substantive stehen in der Regel im Singular.
- Wenn eine Diagnose am Anfang steht und danach Lokalisationsangaben oder Modifikatoren folgen, werden diese durch Kommata abgetrennt und in der Regel in der Nominalform angegeben (z.B. "Appendizitis, akut"). Adjektive und Partizipien werden auch am Textanfang in ihren Nominalformen angegeben.
- Vor den Präpositionen "bei", "mit", "durch" u. Ä. steht immer ein Komma.
- Lateinische Termini technici werden nicht durch Kommata unterbrochen.
- Die Reihenfolge der Lokalisationsangaben und Modifikatoren richtet sich danach, ob der Modifikator zur Diagnose oder zur Lokalisation gehört. Wenn mehrere Modifikatoren nach einer Diagnose stehen, richtet sich die Reihenfolge der Modifikatoren in der Regel nach der besseren Lesbarkeit der Buchfassung.
- Abkürzungen, z.B. einer Diagnose oder einer Lokalisation, werden mit den ausgeschriebenen Begriffen in eckigen Klammern versehen. Ausgenommen davon sind folgende sehr gebräuchliche Abkürzungen:
 - BWS: Brustwirbelsäule
 - HIV: Humanes Immundefizienz-Virus
 - HWS: Halswirbelsäule
 - LWS: Lendenwirbelsäule
 - OP: Operation
 - TBC: Tuberkulose
 - WS: Wirbelsäule
 - ZNS: Zentrales Nervensystem
 - a.n.k.: anderenorts nicht klassifiziert

- Um die Lesbarkeit der Texte zu verbessern, werden Konjunktionen wie "und" und "oder" in den Texten belassen.

4. Qualitätskontrolle

Die Weiterentwicklung des Alphabetischen Verzeichnisses zur ICD-10-GM wird durch eine erweiterte interne und wurde durch eine externe Qualitätskontrolle begleitet. Erkannte Verschlüsselungsfehler werden behoben, alle Änderungen der jeweils aktuellen Version der ICD-10-GM-Fassung werden berücksichtigt.

Zur **externen Qualitätskontrolle** des Alphabetischen Verzeichnisses zur ICD-10-GM wurde ein eigenes Verfahren entwickelt. Es umfasste die folgenden Schritte:

1. Ziehen monatlicher Stichproben aus der EDV-Fassung des Alphabetischen Verzeichnisses zur ICD-10-GM
2. Vorprüfung der Stichproben durch automatische Verfahren
3. Selektion von prüfrelevanten Mengen
4. Manuelle Prüfung der Texte und Kodierungen auf:
 - Korrektheit der Kodierung
 - Rechtschreibung der Diagnosentexte
 - Sinnhaftigkeit der Diagnosentexte
 - Einhaltung der redaktionellen Richtlinien für die Texterstellung für Buch- und EDV-Fassung
 - Vollständigkeit und Korrektheit der Erläuterungen, insbesondere bei Abkürzungen
5. Zusammenfassung der Ergebnisse und Erstellen des Prüfberichts

Das Verfahren wurde unter Leitung von Herrn Dr. med. Albrecht Zaiß bis 2006 am Institut für Medizinische Biometrie und Informatik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br. und von 2007 bis 2015 in der Abteilung Medizincontrolling des Universitätsklinikums Freiburg i.Br. durchgeführt.

Darüber hinaus wurde die externe Qualitätssicherung durch das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland (Zi) unterstützt. Hier dankt das BfArM insbesondere Herrn Dr. med. Bernd Graubner für die Überlassung seiner umfangreichen Korrekturhinweise.